

현미경적 혈뇨(microscopic hematuria)란 소변에 소량의 혈액이 섞여 있지만 눈으로는 보이지 않고 현미경으로만 확인할 수 있는 상태입니다. “무증상”이란 아무런 이상을 느끼지 못하는 상태에서 검사 중 우연히 발견되었음을 뜻합니다. 대부분의 원인은 심각하지 않지만, 드물게 중요한 질환의 초기 징후일 수 있으므로 확인이 필요합니다.

이 질환에 대하여

소변 검사를 통해 소변 색깔을 바꿀 정도는 아닌 소량의 적혈구(red blood cells)를 발견할 수 있습니다. 이는 흔한 소견으로, 그 자체가 진단은 아니며 **좀 더 살펴봐야 한다는 신호**입니다. 의료진은 보통 먼저 요검사(urinalysis)로 실제로 존재하는지 확인합니다 — 시험지봉(dipstick) 검사만으로는 충분하지 않습니다.

원인

원인은 다양하며 대부분 무해합니다:

- **흔하고 양성인 원인:** 격렬한 운동, 최근 감염, 생리, 또는 최근의 성관계
- **치료 가능한 원인:** 요로결석, 전립선비대증(BPH), 또는 신장 질환
- **드문 경우,** 방광이나 신장의 종양의 초기 단서일 수 있습니다 — 그래서 확인이 중요합니다

뚜렷한 원인이 발견되지 않는 경우도 많으며, 이는 안심할 수 있는 소견입니다.

용어 설명

혈뇨(Hematuria)

소변에 혈액이 섞인 상태.

현미경적(Microscopic)

눈으로는 보이지 않고 현미경으로만 확인 가능.

무증상(Asymptomatic)

증상 없이 우연히 발견됨.

요검사(Urinalysis)

혈뇨를 확인하고 정도를 측정하는 소변 검사.

방광경 검사(Cystoscopy)

얇은 카메라로 방광 내부를 직접 보는 검사.

CT 요로조영술(CT urogram)

신장과 요로를 자세히 보는 CT 촬영.

위험도 기반 검사

개인의 위험 요인에 따라 필요한 검사 범위가 결정됨.

걱정해야 하나요? 대부분은 그럴 필요가 없습니다 — 무해한 원인이거나 원인을 찾지 못하는 경우가 많습니다. 검사는 심각한 문제가 예상되어서가 아니라 현명한 예방 조치입니다. 필요한 검사의 범위는 개인의 위험도에 맞게 결정되므로, 모든 사람이 모든 검사를 받는 것은 아닙니다.

진단 방법

의료진은 나이, 흡연 여부(주요 위험 요인), 발견된 혈액량 등 **위험 요인**을 고려하여 적합한 검사를 권장합니다:

- 1 **확인** — 혈뇨가 실제로 있는지 확인하고 병력과 증상을 검토합니다.
- 2 **영상 검사** — 신장과 요로를 **초음파** 또는 **CT 요로조영술**로 확인합니다.
- 3 **방광경 검사** — 위험도가 높은 환자에게 방광 내부를 간단히 살펴보는 검사를 시행합니다.
- 4 신장 질환이 의심되면 **혈액·소변 검사**를 추가합니다.

이후 과정

- 원인이 발견되면 의료진이 **치료**합니다.
- 원인이 없으면 일정 기간 **소변 검사로 경과를 관찰**할 수 있습니다.

알아두세요

- **금연**은 요로 건강을 위해 할 수 있는 가장 중요한 일입니다.
- **혈액희석제(항응고제)**를 복용 중이라면 반드시 알려주세요 — 이 경우에도 검사를 건너뛰어서는 안 됩니다.
- 최근 격렬한 운동, 생리, 또는 감염이 있었다면 의료진에게 알려주세요 — 검사 결과 해석에 도움이 됩니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 소변에 **눈에 보이는 혈뇨**(분홍색·빨간색·갈색), 혈전 동반 여부 무관
- 옆구리나 아랫배 통증, 또는 배뇨 시 따가움
- 발열 또는 소변이 나오지 않는 경우

기억할 세 가지

1. 현미경적 혈뇨는 소변 검사에서 발견된 소량의 혈액입니다 — 대부분 무해하지만 확인은 필요합니다.
2. 검사 범위는 개인의 위험도에 맞게 결정되며, 영상 검사와 방광경 검사가 포함될 수 있습니다.
3. 특히 흡연자라면 검사를 건너뛰지 마세요. **눈에 보이는 혈뇨**가 생기면 즉시 연락하세요.